

PATOLOGÍA ANORRECTAL AGUDA

Oliva López I. Alcoba García L.M.

HEMORROIDES

INTRODUCCIÓN

Son cojinetes mucosos formados por contenido venoso y músculo liso. En ausencia de clínica no precisan tratamiento; pasan a ser hemorroides cuando se dilatan los plexos venosos, tendiendo entonces a ingurgitarse, sangrar y prolapsarse.

Se localizan muy cerca del orificio anal. Constan de 3 nódulos situados a las 3, 7 y 11 horas de la esfera de un reloj.

HEMORROIDES INTERNAS

INTRODUCCIÓN

Dilatación del plexo hemorroidal interno formado por venas **rectales superior y media**. Este plexo se encuentra en el espacio submucoso, por encima de las válvulas de Morgagni.

Clasificación

- Grado I: no sobresalen del canal anal y sangran sin dolor.
- Grado II: se prolapsan durante la defecación y se reducen espontáneamente.
- Grado III: se prolapsan durante la defecación y no se reducen espontáneamente. Precisan reducción manual.
- Grado IV: prolapso permanente y son irreductibles.

DIAGNÓSTICO

Clínica

- **Rectorragia:** sangre roja, no mezclada con las heces. Lo más frecuente es que sea leve aunque en ocasiones puede causar anemia y shock.
- **Prolapso hemorroidal:** exteriorización de hemorroides internas. Se asocia a prurito, manchado (soiling), e incluso necrosis.
- **Crisis hemorroidal aguda:** dolor y edematización de la zona, disconfort, sensación de ocupación.
- **Trombosis hemorroidal:** dolor, induración perianal y coloración violácea. Puede asociarse a fiebre.

Complicaciones

Las complicaciones mas frecuentes pueden ser:

- Trombosis hemorroidal. Son muy dolorosas
- Sangrado rectal.
- Prurito

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- AINES (Ibuprofeno, Enantyum, etc.) de forma pautada.

- Laxantes formadores de bolo fecal (Plantaben sobres).
- Medicamentos flebotónicos (Daflon® 500mg): han demostrado eficacia a dosis elevadas frente a las hemorragias: 6 comprimidos por día durante los primeros 4 días, luego 4 comprimidos por día durante 3 días y finalmente 2 comprimidos al día máximo dos o tres meses.
- Pomadas anestésicas de contacto o con hidrocortisona: de dudoso uso en las crisis hemorroidales.
- Trombectomía bajo anestesia local, en caso de trombosis hemorroidal.
- Si se objetiva necrosis asociada a la trombosis hemorroidal se debe realizar una hemorroidectomía urgente. Avisar a cirugía guardia.

Debe valorarse de forma programada en Consulta de Cirugía General una vez pasada la fase aguda. Es importante descartar otras patologías como el cáncer colorrectal, para lo cual será precisa la realización de una colonoscopia.

- Debe realizarse una colonoscopia programada para descartar neoplasia colorrectal.

HEMORROIDES EXTERNAS

Dilatación de venas hemorroidales o **rectales inferiores**. Se localizan en el tercio distal del canal anal o en el orificio anal, por debajo de la línea dentada, están cubiertas de piel y son muy dolorosas cuando se trombosan.

FISURA ANAL

INTRODUCCIÓN

Ulceración lineal dolorosa punzante que se extiende desde la línea pectínea hasta el margen anal, generalmente en la línea media posterior, asociada a hipertonía del esfínter.

DIAGNÓSTICO

- Clínica:
 - Dolor anal intenso lacerante asociado a la defecación. Se presenta a su vez con sangre fresca tras la deposición.
 - Estreñimiento, como consecuencia del dolor de la deposición.
 - “Hemorroide centinela”: no es una hemorroide propiamente dicha, sino de una inflamación del extremo inferior de la herida.
 - Hipertonía del esfínter interno (EI): el dolor causa espasmo reflejo del EI que condiciona mayor dolor y mala irrigación de los bordes de la fisura, lo cual impide su correcta cicatrización y se inicia un círculo vicioso de herida-dolor-hipertonía-isquemia-herida.
- Exploración física: Se objetiva úlcera en margen anal (normalmente en cara posterior) e hipertonía del esfínter.

- No se debe realizar tacto rectal por la intensa hipertonía del esfínter anal.

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.
- Laxantes formadores de bolo (Plantaben) o aceites de parafina: pueden asociarse en

presencia de estreñimiento.

- Analgésicos de forma pautada en las crisis dolorosas. Puede asociarse un relajante muscular (Diacepam), o incluso infiltración con anestésico local.
- Uso de crema cicatrizante como el Levorag®.
- Uso de cremas que disminuyen la hipertonía del esfínter (Rectogesic®). Se puede utilizar durante 2 meses. Efecto adverso: cefalea; si se presenta se debe suspender el tratamiento y acudir a consulta de cirugía general.
- Toxina botulínica: alivia la hipertonía del esfínter.

El tratamiento definitivo es quirúrgico, que consiste en una esfinterotomía lateral interna.

ABSCESOS ANORRECTALES

INTRODUCCIÓN

Los abscesos anorrectales son colecciones de material purulento en espacios adyacentes al ano y/o recto. El 90% son de origen criptoglandular, aunque también puede ser secundario a una fístula anorrectal.

La mayoría de los abscesos se originan en la línea pectínea



Clasificación

- Interesfinterianos: situados entre el músculo liso del esfínter interno y el músculo estriado del esfínter externo.
- Submucosos: drenan hacia el canal anal.
- Perianales.
- Isquiorrectales.
- Supraelevadores.

DIAGNÓSTICO

- **Clínica:**
 - Dolor de inicio difuso, perianal, asociado a malestar general y fiebre.
 - Molestias con la defecación.
 - Tumefacción en la región del periano.
 - Calor local.
 - Enrojecimiento.

- Gangrena de Fournier: es la complicación más grave de un absceso.
- **Exploración física:**
 - Según su localización puede variar presentándose más frecuentemente como una tumoración dolorosa y ocasionalmente fluctuante en zona perianal.
 - Los abscesos submucosos e interesfinterianos no presentan signos inflamatorios externos. Cursan con dolor anal y al tacto rectal se evidencia tumoración lisa en la parte superior del canal anal y recto inferior, muy dolorosa.
 - Los abscesos supraelevadores suelen ser de difícil diagnóstico ya que se presentan con una sintomatología más insidiosa, sin objetivarse alteraciones perianales, en un paciente séptico con disconfort en zona anal / pélvica. Precisa de una prueba de imagen para su diagnóstico.

- La gangrena de Fournier es una complicación quirúrgica urgente.

TRATAMIENTO

Drenaje y desbridamiento quirúrgico bajo anestesia general o regional. Se deben asociar antibióticos sólo en inmunodeprimidos, diabéticos, cardiopatas con prótesis valvulares y pacientes sépticos.

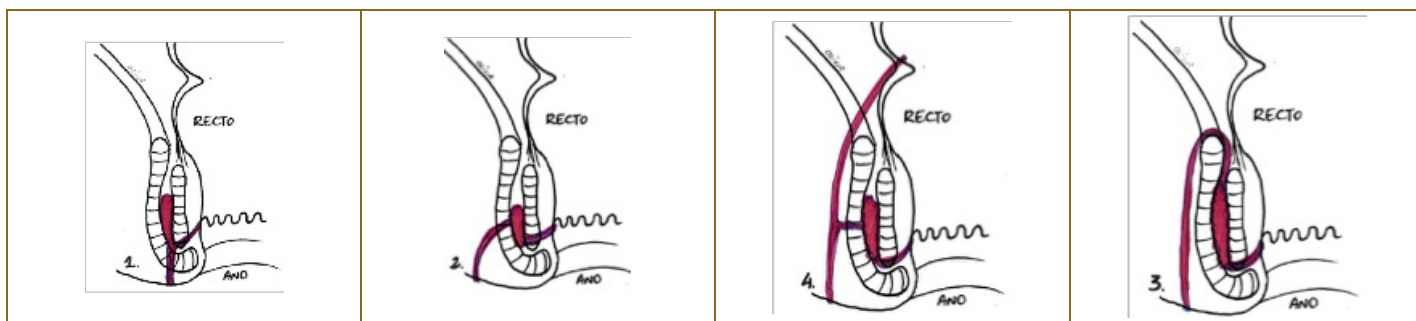
FÍSTULA ANAL

INTRODUCCIÓN

La fístula es una conexión entre dos superficies epitelizadas como el canal anal y la piel, que puede atravesar por completo o parcialmente las estructuras musculares perianales. La fístula es la manifestación crónica de un absceso.

Clasificación

- Interesfintérica.
- Transesfintérica.
- Supraesfintérica.
- Extraesfintérica.
- En herradura.



DIAGNÓSTICO

- Clínica: secreción de pus, líquido serohemático o fecaloideo por el orificio externo.
- Exploración física: Identificación del orificio externo en la inspección. En el tacto rectal se puede palpar el trayecto fistuloso u orificio interno.

TRATAMIENTO

- Medidas higiénico-dietéticas: baños de asiento con agua tibia, evitar el uso de papel higiénico

tras la defecación, evitar el estreñimiento (dieta rica en fibra e ingesta abundante de líquidos), evitar comidas picantes, excitantes, café, chocolate, tabaco o alcohol.

- Laxantes formadores de bolo (Plantaben): pueden asociarse en presencia de estreñimiento.
- Analgesia pautada.
- Remitir a Consulta Externa de Cirugía General.
- Si se encuentra en la fase aguda de absceso precisa drenaje y desbridamiento.

SINUS PILONIDAL

INTRODUCCIÓN

Formación quística en área sacrococcígea a nivel medial con tejido de granulación, fibrosis e inclusiones pilosas, pudiendo evolucionar a una sobreinfección con la posterior formación de un absceso.

DIAGNÓSTICO

- Clínica: presenta los síntomas habituales de un absceso: calor, dolor, tumefacción y rubor.
- Exploración física: absceso sacrococcígeo doloroso y fluctuante.

TRATAMIENTO

- En la fase aguda de abscesificación: drenaje y desbridamiento bajo anestesia local.
- Derivar al paciente a consulta externa de Cirugía General para exéresis en bloque del sinus una vez haya pasado la fase de absceso.

PATOLOGÍA	CLÍNICA	EXPLORACIÓN	TACTO RECTAL	TRATAMIENTO
Hemorroides	• Dolor, prolapso, hemorragia.	• Congestivas y edematizadas.	• Doloroso.	• Analgesia, Daflon®.
Trombosis hemorroidal	• Dolor intenso.	• Uno o varios nódulos violáceo-negrucos.	• Nódulos duros y dolorosos.	• Trombectomía.
Fisura anal	• Dolor intenso durante la defecación asociado a rectorragia.	• Úlcera en línea media posterior del ano.	• No realizar.	• Analgesia. • Rectogesic. • Quirúrgico.
Absceso anorrectal	• Dolor zona anal, fiebre.	• Tumorción perianal dolorosa, fluctuante.	• Normal o tumoración dolorosa en canal anal.	• Desbridamiento y drenaje quirúrgicos.
Fístula anal	• Supuraciones esporádicas. Prurito.	• Secreción purulenta por orificio externo.	• No doloroso. En ocasiones se palpa el orificio interno.	• Quirúrgico. Derivar a cirugía general.
Sinus pilonidal	• Dolor y tumoración sacrococcígea. Fiebre.	• Absceso fluctuante en línea media sobre sacro y cóccix.	• No doloroso.	• Drenaje.

BIBLIOGRAFÍA

- Abcarian H. Anorectal infection: abscess-fistula. Clin Colon Rectal Surg. 2011;24(1):14-21.

- Anal abscess/fistula. American Society of Colon & Rectal Surgeons. [Internet]. 2008. [Accessed on April 25, 2011]. Disponible en: www.fascrs.org/patients/conditions/anal_abscess_fistula
- Jacobs D. Clinical practice. Hemorrhoids. N Engl J Med 2014; 371(10): 944-51.